

Distocias

1. Introducción y relevancia clínica

El término **distocia** significa literalmente “*parto difícil*” y engloba cualquier **anormalidad en el progreso del trabajo de parto** debida a alteraciones en los tres factores esenciales que determinan el parto:

Las 3 P:

- **Poderes (Power):** contracciones uterinas y esfuerzo expulsivo.
- **Pasaje (Passage):** pelvis ósea y partes blandas del canal del parto.
- **Pasajero (Passenger):** feto (tamaño, posición, presentación y actitud).

La identificación temprana de una distocia es vital, ya que su persistencia **aumenta el riesgo de sufrimiento fetal, infección, hemorragia postparto y cesárea.**

□ En EUNACOM es frecuente encontrar preguntas del tipo:

“Gestante con 6 cm de dilatación que no progresa tras 4 horas con contracciones adecuadas
→ diagnóstico: distocia dinámica o desproporción cefalopélvica.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El trabajo de parto normal requiere la interacción armónica entre los tres componentes:

1. **Contracciones uterinas efectivas** → borran y dilatan el cuello.
2. **Pelvis de tamaño y forma adecuada.**
3. **Feto con presentación, posición y actitud normales.**

La alteración de cualquiera de ellos interrumpe el progreso fisiológico.

Las distocias se clasifican en cuatro grandes grupos:

Tipo de distocia

Mecanismo principal

Dinámica	Anormalidad en contracciones uterinas
De presentación o posición fetal	Actitud o encajamiento anormal
De pelvis	Desproporción cefalopélvica
De partes blandas	Obstrucción en el canal del parto

3. Distocias dinámicas (de los “poderes”)

A.

Hipodinamia (inercia uterina)

Contracciones uterinas débiles, infrecuentes o de corta duración.

Criterios clínicos:

- <3 contracciones cada 10 minutos.
- Duración <40 s o intensidad <25 mmHg.
- Progreso cervical lento o ausente.

Causas:

- Fatiga uterina.
- Sedación excesiva o anestesia epidural.
- Sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios).
- Cuello inmaduro o distensión cervical.

Manejo:

1. Corregir causas reversibles (hidratación, vejiga vacía, reposo).
 2. Estimulación con **oxitocina en infusión continua**, titulando dosis.
 3. Vigilar sufrimiento fetal y respuesta uterina.
-

B.

Hiperdinamia o taquisistolia

Más de 5 contracciones en 10 minutos o contracciones prolongadas >90 s.

Consecuencias: hipoxia fetal por reducción de perfusión placentaria.

Causas:

- Exceso de oxitocina o prostaglandinas.
- Hipersensibilidad uterina.
- Desprendimiento de placenta normoinserta.

Manejo:

- Suspender oxitocina o prostaglandinas.
 - Oxígeno materno, posición lateral izquierda, hidratación.
 - Si persiste: tocolítico (salbutamol, atosiban).
-

C.

Descoordinación uterina

Contracciones irregulares, asincrónicas, dolorosas e inefectivas.

Más frecuente en primíparas ansiosas.

Manejo:

- Sedación leve (diazepam, petidina) o analgesia epidural.

- En casos refractarios, cesárea.
-

4. Distocias del pasajero (feto)

A.

De presentación

1. Presentación de frente o facial

- **Frontal:** imposible el parto vaginal (diámetro occipitomentoniano 13,5 cm).
- **Facial:** posible solo si mentón anterior (mentoanterior).
- Si mentón posterior → **cesárea**.

2. Presentación de pelvis (podálica)

- En general → **cesárea electiva**, salvo multíparas con feto pequeño y parto avanzado.

3. Presentación de hombro (transversa)

- Parto vaginal imposible → **cesárea obligatoria**.
-

B.

De posición

Posición anómala del occipucio (occípito posterior persistente o transversa).

Manifestaciones:

- Trabajo prolongado.
- Dolor lumbar intenso.
- Tacto vaginal: sutura sagital en diámetro transversal o posterior.

Manejo:

- Esperar rotación espontánea (80% se corrige a anterior).
 - Si persiste → rotación manual o fórceps rotador.
 - Si no progresa → cesárea.
-

C.

De actitud

Deflexión de la cabeza fetal → aumenta el diámetro de presentación.

Actitud	Diámetro	Consecuencia
Flexión (normal)	Suboccipitobregmático 9,5 cm	Favorable
Deflexión media (sincipital)	Occipitofrontal 11,5 cm	Parto dificultoso
Deflexión marcada (frontal/facial)	>13 cm	Cesárea

5. Distocias del pasaje (pelvis y partes blandas)

A.

Desproporción cefalopélvica (DCP)

Discrepancia entre tamaño fetal y dimensiones pélvicas.

Diagnóstico clínico:

- Progreso detenido de dilatación o descenso pese a buena dinámica.
- Presentación alta, no encajada, que “rebota” al tacto.

- Dolor intenso sin avance del parto.

Confirmación: examen pélvico o pelvimetría (radiológica o clínica).

Manejo:

- Si DCP absoluta → cesárea.
 - Si relativa → prueba de trabajo de parto vigilado con oxitocina.
-

B.

Alteraciones pélvicas

Tipos según Caldwell-Moloy:

- **Ginecoide:** pelvis ideal (50% de mujeres).
 - **Androide:** estrecho posterior → trabajo prolongado.
 - **Antropoide:** diámetro anteroposterior amplio, favorable.
 - **Platipeloide:** estrecho transversal → encajamiento difícil.
-

C.

Distocia de partes blandas

Obstrucción del canal por:

- Tumores pélvicos o miomas cervicales.
- Vejiga o recto lleno.
- Vagina o periné rígido (primíparas, cicatrices).

Manejo: vaciar vejiga, episiotomía, o cesárea según el caso.

6. Diagnóstico y evaluación del progreso del parto

Partograma

Herramienta fundamental para detectar distocia.

- Registra dilatación, contracciones, descenso fetal y FCF.
- **Línea de alerta:** dilatación mínima esperada (1 cm/h).
- **Línea de acción:** 4 h a la derecha → requiere intervención.

☐ Si la paciente cruza la línea de acción sin progresar, debe evaluarse causa: dinámica, pelvis o feto.

Evaluación de la dinámica uterina

- Frecuencia, duración e intensidad de contracciones.
- Monitorización con tocodinamómetro o catéter de presión intrauterina.

Evaluación fetal

- Tacto vaginal: suturas, fontanelas, plano de Hodge.
- Ecografía: presentación y posición.
- Monitoreo fetal continuo.

7. Manejo general de la distocia

1. **Evaluar causa:** dinámica, pasajero o pelvis.
2. **Asegurar bienestar fetal y materno.**
3. **Corrección dirigida:**

- Si hipodinamia → oxitocina.
 - Si hiperestimulación → suspender fármacos.
 - Si mala posición → rotación manual o cesárea.
 - Si DCP → cesárea.
4. **Reevaluar cada 2 horas con tacto y partograma.**
 5. **Cesárea si no hay progreso tras manejo adecuado.**

8. Complicaciones asociadas

Complicación	Mecanismo	Riesgo
Sufrimiento fetal agudo	Hipoxia por parto prolongado o hiperdinamia	Alto
Infección materno-fetal	Trabajo prolongado con rotura de membranas	Alto
Hemorragia posparto	Atonía uterina tras fatiga miometrial	Alto
Rotura uterina	DCP o hiperdinamia severa	Grave
Trauma fetal	Maniobras forzadas	Variable

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Distocia = alteración del progreso del trabajo de parto.
2. **Tres causas principales:** poder, pasaje o pasajero.
3. **Hipodinamia:** <3 contracciones/10 min → oxitocina.
4. **Hiperestimulación:** >5/10 min → suspender oxitocina.
5. **Presentación transversa o frontal:** cesárea obligatoria.
6. **Partograma** es la herramienta esencial para diagnóstico.
7. **Plano de Hodge III:** presentación fija → progreso adecuado.



Errores comunes

- Administrar oxitocina sin descartar DCP.
- No registrar partograma o ignorar línea de acción.
- No reconocer occípito posterior persistente.
- Intentar parto vaginal con presentación transversa.
- Confundir detención de dilatación con fase latente prolongada.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Distocia:** alteración del progreso del trabajo de parto por falla en los “3 P”.
2. **Hipodinamia:** contracciones débiles → oxitocina.
3. **Hiperestimulación:** exceso de contracciones → suspender fármacos.
4. **Presentación anómala (frontal, transversa, podálica):** cesárea.
5. **Desproporción cefalopélvica:** diagnóstico clínico → cesárea.
6. **Partograma:** herramienta central para detectar y manejar distocia.
7. **Objetivo final:** parto seguro sin sufrimiento fetal ni trauma materno.